



Dolor de garganta. Odinofagia

N. Pérez Marrero^{a,*}, M. Rodríguez Paradinas^a, M. Alcázar Ruano^a y T. Rivera-Rodríguez^{a,b}

^aServicio de Otorrinolaringología. Hospital Universitario Príncipe de Asturias. Alcalá de Henares. Madrid. España. ^bDepartamento de Medicina. Universidad de Alcalá. Alcalá de Henares. Madrid. España.

Palabras Clave:

- Odinofagia
- Dolor de garganta

Keywords:

- Odynophagia
- Sore throat

Resumen

El dolor de garganta puede presentarse como el síntoma principal de una serie amplia de diagnósticos diferenciales. Una historia clínica meticulosa permite diferenciar los casos potencialmente autolimitados de aquellos que precisan más evaluación y que posiblemente deberán ser derivados para valoración hospitalaria por un especialista.

La odinofagia puede llevar asociados otros síntomas que se deben conocer. Hay que realizar un diagnóstico diferencial correcto que nos permita determinar la etiología más frecuente y así poder evitar las posibles complicaciones asociadas.

El diagnóstico es fundamentalmente clínico, aunque existen métodos de diagnóstico específicos. El tratamiento habitual es con antibióticos, teniendo en cuenta la posible etiología y las resistencias a los mismos.

Abstract

Sore throat. Odynophagia

Sore throat may present as the main symptom in a wide range of differential diagnoses. A meticulous medical history allows for differentiating potentially self-limited cases from those that require further evaluation and may need to be referred for inpatient evaluation by a specialist.

Odynophagia may be associated with other symptoms, which must be known. A correct differential diagnosis must be made in order to determine the most frequent etiology and thus avoid possible associated complications.

The diagnosis is primarily clinical, although there are specific diagnostic methods. The usual treatment is antibiotics, taking into account the possible etiology as well as antibiotic resistance.

Introducción

El dolor de garganta es uno de los motivos de consulta más habituales en la consulta de atención primaria, pediatría y otorrinolaringología¹. Es frecuentemente atribuible a infecciones autolimitadas (faringoamigdalitis aguda —FAA—) y se asume que el 70% de los casos presentan una etiología vírica².

En promedio, los adultos presentan de dos a cuatro episodios de infecciones respiratorias de las vías altas al año y en

niños la frecuencia es de hasta seis a ocho episodios, especialmente durante los meses con menores temperaturas³.

Aunque las causas más frecuentes de dolor de garganta son habitualmente benignas y el curso de la enfermedad es típicamente leve, la incidencia elevada anual se traduce en un impacto importante en la salud pública en cuanto a descenso en productividad, implicando en promedio hasta 6,5 días de baja por episodio, y el sobreuso de antibióticos, lo cual representa un riesgo innecesario para los pacientes y promueve el desarrollo de resistencia antibiótica⁴.

Se ha descrito la tendencia a la prescripción de tratamiento antibiótico en un 47% de los pacientes con dolor de garganta en Estados Unidos⁵, un 74% de los pacientes en España⁶ y entre 76%-84% en Bélgica⁷. A pesar de esto, el

*Correspondencia
Correo electrónico: nathypuig@gmail.com

patógeno bacteriano más frecuente, *Streptococcus pyogenes* o betahemolítico del grupo A (EBHGA) supone tan solo el 20%-30% de los casos de FAA en niños y el 5%-15% en adultos^{2,4,8}.

En la práctica clínica es más importante el diagnóstico de las FAA producidas por EBHGA². Suele ser muy poco frecuente antes de los 3 años, posteriormente tiene un pico de máxima incidencia entre los 5 y 15 años, luego desciende a un 5%-23% en los adultos jóvenes, y vuelve a ser muy poco frecuente en mayores de 50 años⁹.

Como factores de riesgo destacan los antecedentes familiares infecciosos, las condiciones de hacinamiento y la contaminación ambiental, incluyendo en esta última el tabaquismo crónico. Todos los grupos poblacionales están igualmente expuestos, independientemente de su nivel socioeconómico o profesión¹⁰.

Se define el dolor de garganta como crónico cuando ha persistido durante más de 14 días. Entre los diagnósticos diferenciales del dolor de garganta crónico es menos probable la etiología infecciosa, por lo que es preciso plantearse otros factores como los antecedentes recientes de intubación, el hábito tabáquico, el ronquido, los efectos adversos de medicamentos, el reflujo y el sobreuso vocal o en asociación con disfonía por tensión muscular, entre otros.

Actualmente la recomendación de tratamiento antibiótico rutinaria se reserva para pacientes entre 2-25 años en comunidades con alta incidencia de fiebre reumática aguda, pacientes con patología cardíaca reumática previa y pacientes con escarlatina¹¹.

Recuerdo anatómico

La garganta anatómicamente abarca la faringe y laringe. Se inicia superiormente a nivel de la base del cráneo y nasofaringe, extendiéndose caudalmente hacia la zona proximal del esófago y de la tráquea. Se halla en proximidad a la cavidad nasal y la cavidad oral. La laringe se divide en supraglotis, glotis y subglotis y la faringe en nasofaringe, orofaringe e hipofaringe.

La inervación sensorial de la garganta está dada por los nervios glossofaríngeo y vago. Estos también están involucrados en la sensibilidad de los oídos, por lo que se puede observar una otalgia refleja como síntoma principal en procesos que tienen su origen en la garganta⁴.

Historia clínica

El dolor de garganta puede presentarse como el síntoma principal de una serie amplia de diagnósticos diferenciales. Una historia clínica meticulosa permite diferenciar los casos potencialmente autolimitados de aquellos que precisan más evaluación, y posiblemente deberán ser derivados para su valoración hospitalaria por un especialista.

El síntoma definido como «dolor de garganta» puede implicar irritación, prurito, sensación urente o dolor como tal, por lo que se recomienda solicitar al paciente una descripción específica. Además, pueden referir dolor de garga-

ta como un punto muy localizado o la totalidad de las zonas implicando laringe, faringe y partes blandas del cuello.

En general, los dolores bien localizados son más alarmantes que los que se describen con una localización más difusa.

La duración de los síntomas es un indicador importante. Cualquier odinofagia que persiste más de 3 semanas o que aumenta progresivamente de intensidad precisa un estudio más exhaustivo⁴.

Posibles síntomas asociados

Odinofagia

La odinofagia es dolor durante la deglución y se manifiesta particularmente en relación con procesos infecciosos o inflamatorios, por ejemplo: FAA, absceso periamigdalino, epiglotitis, infección micótica faríngea, etc. Muchas veces la ausencia de odinofagia permite esclarecer el diagnóstico, siendo más habitual el síntoma irritativo de garganta en relación con el reflujo laríngeo o el goteo nasal posterior⁴.

Fiebre

La fiebre se presenta ocasionalmente en casos de origen infeccioso. En pacientes inmunosuprimidos, la presencia o ausencia de fiebre es un indicador poco fiable.

Sensación de ocupación faríngea

Se trata de la sensación de un cuerpo extraño en la garganta. Entre sus diagnósticos diferenciales pueden hallarse neoplasias, granulomas de cuerdas vocales, FAA o un cuerpo extraño. Los pacientes con dolor de garganta crónico deben ser interrogados sobre antecedentes de alergias o reflujo, y a los síntomas puede asociarse el dolor urente epigástrico, el aclaramiento crónico de secreciones faringolaríngeas y la disfonía intermitente⁴.

Alteraciones en la voz

En los abscesos periamigdalinos puede observarse una alteración de la voz, «voz gangosa», que ocurre por inflamación de la musculatura periamigdalina y edema que limitan la movilidad del paladar, alterando la resonancia durante la fonación⁴.

Compromiso de la vía aérea

Puede presentarse un rango variable de síntomas obstructivos: estridor, taquipnea, posición en inclinación anterior con extensión del cuello, sialorrea, cianosis u obstrucción completa de la vía aérea.

Entre los diagnósticos diferenciales con obstrucción de la vía aérea se describen la supraglotitis o epiglotitis, los abscesos retrofaríngeos, los abscesos o masas parafaríngeas y las masas laríngeas o parafaríngeas obstructivas.

Síntomas nasales

La congestión nasal y la rinorrea pueden presentarse en relación con alergias estacionales o en infecciones de las vías respiratorias altas de etiología vírica. La obstrucción nasal puede implicar la aparición de ronquido y la respiración oral crónica durante el día y/o la noche que puede generar sequedad e irritación faríngea y dolor de garganta con empeoramiento matutino.

Tos

Este síntoma implica la presencia de irritación de la vía aérea. La tos irritativa o la necesidad de aclarar frecuentemente secreciones pueden asociarse con reflujo faringolaríngeo o con goteo nasal posterior.

La tos asociada con dolor de garganta es más frecuente en un contexto de infecciones víricas agudas.

La tos puede persistir tras la resolución del dolor de garganta y de otros síntomas víricos por irritación del nervio laríngeo recurrente.

Adenopatías cervicales

Habitualmente están asociadas a etiologías reactivas, infecciosas o neoplásicas. La ubicación de las adenopatías es un dato relevante para concretar el diagnóstico diferencial; una adenopatía cervical posterior puede hallarse en relación con mononucleosis, las adenopatías laterocervicales suelen estar más presentes en las faringitis estreptocócicas que en otras causas de faringitis⁴.

Etiología

Las causas más habituales de dolor de garganta se resumen en la tabla 1.

Faringitis vírica

Es significativamente la causa más frecuente de dolor de garganta; los virus habitualmente implicados incluyen rinovirus, coronavirus, adenovirus, virus parainfluenza, virus de influenza, virus coxsackie, virus del herpes simple, virus de Epstein-Barr (VEB), citomegalovirus y virus de la inmunodeficiencia humana.

La faringitis vírica se trata habitualmente adoptando una conducta expectante y mediante enfoque de tratamiento sintomático que implica abundante hidratación, antipiréticos y analgesia, sin precisar más evaluación, con excepción del vi-

TABLA 1

Causas comunes de dolor de garganta

Origen	Etiología
Infeccioso	Faringitis vírica
	Gripe
	Mononucleosis
	Faringitis estreptocócica
	Faringoamigdalitis bacteriana no estreptocócica
	Absceso periamigdalino
	Amigdalitis
	Candidiasis oral
	Infecciones de espacios profundos cervicales (retrofaríngeo/parafaríngeo)
	Epiglotitis/supraglotitis
	Laringitis fúngica
	Herpangina
	Sífilis
	Síndrome de Lemierre
Inflamatorio	Infección por fusospiroquetas (angina de Vincent)
	Reflujo faringolaríngeo
	Cuerpo extraño
	Mucositis
	Granulomas de cuerdas vocales
	Enfermedades granulomatosas
	Enfermedad de Kawasaki
	Pénfigo
	Respiración oral crónica
Neoplásico	Rinitis alérgica con goteo postnasal
	Disfonía por tensión muscular
	Carcinoma de células escamosas
	Sarcoma
	Linfoma
	Adenocarcinoma

Adaptada de Chan T⁴.

rus de la influenza y VEB. Desde 2020 es necesario incluir la COVID-19 entre los diagnósticos diferenciales de pacientes con síntomas respiratorios de nueva aparición.

Mononucleosis

Infección causada por el VEB. Los síntomas incluyen dolor de garganta, fiebre elevada, fatiga extrema durante una o más semanas, inflamación amigdalar con o sin exudados y adenopatías cervicales voluminosas anteriores y posteriores; también se asocia una erupción cutánea leve y la aparición de petequias en el paladar. Puede observarse también hepatomegalia o esplenomegalia.

Los pacientes con estos síntomas deberían evaluarse analíticamente mediante hemograma y test rápido para la detección de anticuerpos; si existen dudas etiológicas puede hacerse también una prueba de detección de antígeno de estreptococo.

Habitualmente en el hemograma se observa linfocitosis con más del 10% de linfocitos atípicos y puede asociarse a trombocitopenia.

El tratamiento es de soporte, implicando reposo, hidratación y antipiréticos. Los antibióticos y antiviricos no están

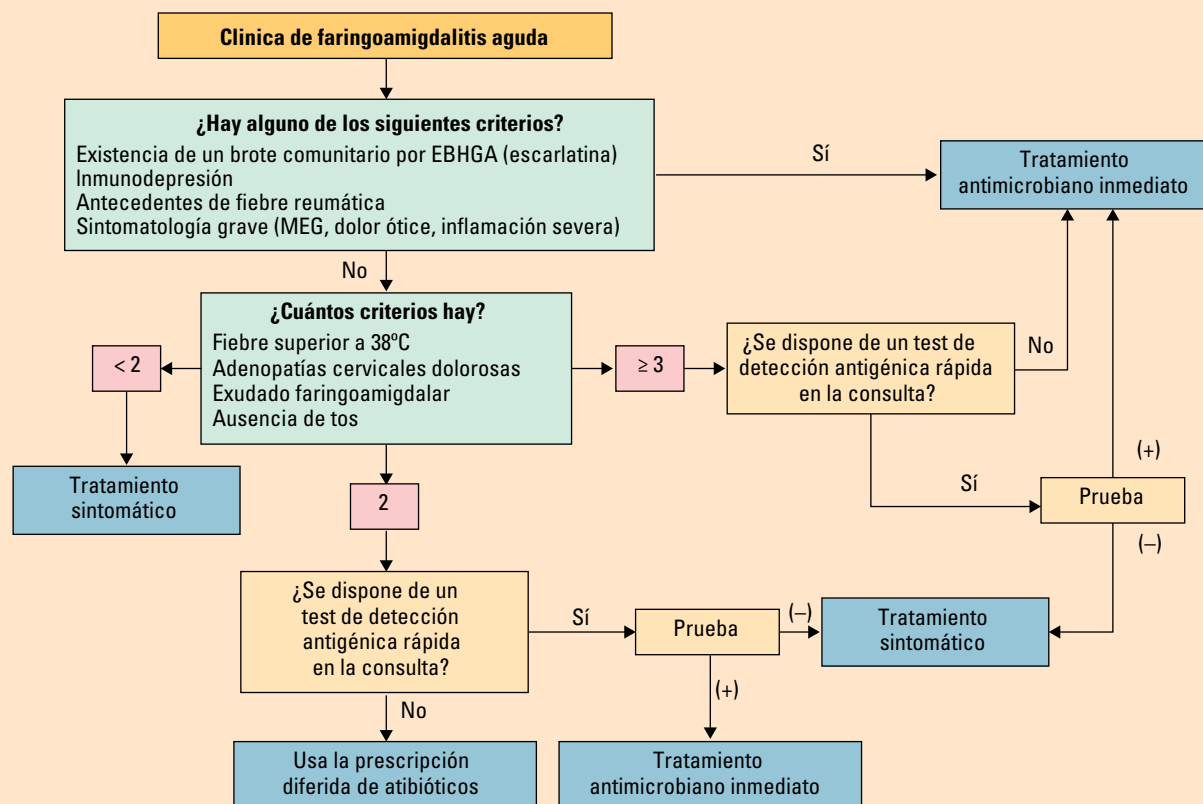


Fig. 1. Abordaje recomendado de la faringoamigdalitis aguda en el adulto. Adaptada de Cenjor C, et al⁸.

indicados en el tratamiento de la mononucleosis. La ampicilina específicamente debe ser evitada en pacientes con sospecha de mononucleosis, ya que puede ocasionar una erupción cutánea pruriginosa en la mayoría de los pacientes.

Virus de la influenza. Gripe

Aunque su forma de presentación es similar al catarro común con dolor de garganta, fiebre y tos, representa un riesgo de salud pública global con potencial evolución hacia la pandemia; es un virus con gran tendencia a la mutación, por lo que las vacunas deben actualizarse anualmente.

Faringitis bacteriana y amigdalitis

Muchas bacterias pueden causar esta entidad, las involucradas con más frecuencia son los estreptococos, *Corynebacterium diphtheriae*, *Neisseria gonorrhoeae*, *Chlamydia pneumoniae* y *Mycoplasma pneumoniae*.

Los EBHGA son los predominantes como organismo causante. El estreptococo es la única causa de faringitis en la que están indicados formalmente los antibióticos (fig. 1).

Son infecciones más frecuentes durante el invierno o al inicio de la primavera. Los pacientes presentan dolor de garganta, odinofagia, fiebre y linfadenopatías cervicales anterior-

res. Clínicamente se asocia a eritema de los pilares amigdalares y de amígdalas con exudados.

Los hallazgos clínicos muchas veces se superponen. Así, hasta un 65% de las FAA víricas cursan con exudado faríngeo y un 30% de las bacterianas pueden cursar sin exudado¹².

Incluso con menor frecuencia, la FAA puede estar causada por *Fusobacterium necrophorum*, *Borrelia vincentii*, *Arcanobacterium haemolyticum*, *Neisseria gonorrhoeae*, *Mycoplasma pneumoniae* y *Chlamydia pneumoniae*^{13,14}.

Métodos de diagnóstico

Escalas clínicas

Las escalas permiten estimar la probabilidad de detección microbiológica de estreptococos beta hemolíticos en un hisopado amigdal durante una FAA.

Se asigna un punto a cada ítem definido por hallazgos en la evaluación médica, permitiendo la reducción de administración de antibióticos sin aumento de complicaciones o de reingresos.

Se recomienda la determinación de una escala clínica (tabla 2) en pacientes mayores de 3 años con odinofagia aguda y sin signos de alarma asociados en caso de estar planteando la posibilidad de prescribir tratamiento antibiótico.

TABLA 2
Escala clínica de evaluación de riesgo para faringoamigdalitis aguda por estreptococos beta hemolíticos

Criterios clínicos	FeverPAIN score (> 3 años)	Criterios de Centor (> 15 años)	McIsaac score (> 3 años)
Fiebre	+1	+1	+1
Exudados amigdalares	+1	+1	+1
Ausencia de tos	+1	+1	+1
Adenopatías cervicales	0	+1	+1
Eritema e inflamación amigdalar prominente	+1	0	0
Edad			< 15 años: + 1 > 45 años: - 1

Adaptada de Krüger K, et al¹ y Piñeiro Pérez R, et al¹³

TABLA 3
Signos de alarma en pacientes con dolor de garganta y actuación recomendada en esos casos

Sospecha de escarlatina	Sospecha de absceso periamigdalino	Estridor o disnea (sospecha de epiglotitis o mononucleosis)	Diagnóstico diferencial (ejemplo: mononucleosis)
Sospecha de mononucleosis infecciosa	Sospecha de neoplasia	Signos de enfermedad sistémica severa (meningitis, difteria, síndrome de Lemierre, síndrome de Kawasaki)	Signos o síntomas de patología grave o sistémica
Infección con otro foco de origen (neumonía, bronquitis, otitis media, sinusitis)	Persistencia de odinofagia > 6 semanas	Signos de complicaciones supurativas (absceso periamigdalino/parafaríngeo/retrofaringeo)	Resistencia a antibióticos (si uso previo)
Riesgo alto de fiebre reumática aguda	Faringoamigdalitis aguda recurrente	Deshidratación	
Comorbilidades severas			

Adaptada de Krüger K, et al¹.

Criterios de predicción diagnóstica

Si el riesgo es bajo (menos de 3 puntos) no está indicado el tratamiento antibiótico. Si es moderado (3 puntos) se recomienda una prescripción tardía de antibióticos. Si es mayor de 3 puntos se debe administrar antibiótico inmediatamente. La primera opción terapéutica es penicilina V vía oral con claritromicina como alternativa para los intolerantes o alérgicos a penicilinas. El tratamiento debe cumplirse durante 5-7 días.

Se recomienda el tratamiento antibiótico en pacientes con 4-5 puntos en la escala modificada de Centor (McIsaac), 2-3 puntos en la escala solo si la detección de test de detección rápida de antígeno es positiva y evitar el tratamiento antibiótico en aquellos pacientes con 0-1 de puntuación.

Adicionalmente se cuantifican según los siguientes criterios de edad: menos de 3 años -1 punto; de 3-14 años 1 punto; entre 15-44 años 0 puntos y más de 45 años -1 punto².

Los criterios de Centor tienen un valor predictivo negativo del 81% y un valor predictivo positivo del 48%⁴. Sin embargo, su utilidad en niños parece menor en comparación con los adultos, dadas algunas diferencias clínicas en la presentación del dolor de garganta en los primeros años de vida³.

Pacientes de riesgo

Se considera especialmente a pacientes con inmunosupresión severa: uso de corticoides sistémicos a largo plazo, trasplante de órganos, trasplante de células madre, SIDA, neutropenia y otras alteraciones inmunes congénitas o adquiridas.

Es imprescindible saber manejar a estos pacientes y hacer un seguimiento adecuado en función de la gravedad del caso (tabla 3).

Confirmación etiológica

Existen tres modalidades de confirmación de infección por estreptococo de grupo A: cultivo de faringe, test rápido de detección de antígeno estreptocócico (Strep A) y ELISA^{4,15}.

Detección rápida de estreptococos del grupo A y cultivo microbiológico

Se apoya el uso de estos en caso de probabilidad media o alta de faringitis en las escalas (3 o más puntos) en pacientes pediátricos entre 3-15 años dada su tendencia elevada a faringitis por estreptococos de este grupo. En caso de ser negativo se evita la indicación del tratamiento antibiótico.

El cultivo microbiológico no se recomienda rutinariamente antes o después del tratamiento antibiótico. Se aplican excepciones en pacientes con signos de enfermedades de notificación obligatoria, enfermedades que precisen tratamiento específico, patógenos atípicos en el contexto de inmunosupresión y riesgo de fiebre reumática aguda¹⁶.

Si se realiza una prueba de detección rápida y es negativa, no es necesario realizar posteriormente un cultivo de confirmación del resultado³.

Un aspecto a considerar es que la positividad del Strep A no distingue infección aguda de estado de portador, aspecto que tampoco lo hace el cultivo. Los porcentajes de portado-

res asintomáticos pueden llegar al 20% entre los niños, pero su prevalencia en adultos no llega al 5%.

Las pruebas de detección antigénica rápida empleadas para el diagnóstico etiológico de la FAA son específicas para el EBHGA y no descartan otras etiologías como las producidas por *S. dysgalactiae* y *S. anginosus*, cuyas manifestaciones clínicas son similares. En un estudio reciente se observó que tampoco evitan la aparición de complicaciones cuando sus resultados son falsos negativos¹⁷.

La prueba de diagnóstico rápido utilizada actualmente en Atención Primaria es el Strep A; su uso se recomienda únicamente en los casos en que se sospeche una probable infección estreptocócica. En los pacientes con ningún o un criterio de Centor no se recomienda la realización de test diagnóstico ni de tratamiento con antibiótico.

Complicaciones de las infecciones por estreptococos betahemolíticos del grupo A

Complicaciones supurativas

Ocurren por la afectación de las estructuras próximas al foco de infección o por la extensión de la infección en relación con sus zonas de drenaje. Más frecuentemente se presenta el flemón y el absceso periamigdalino, el absceso retrofaríngeo, la otitis media aguda, la sinusitis, la mastoiditis y la adenitis cervical supurativa.

Más excepcionalmente se presenta tromboflebitis de la vena yugular interna (síndrome de Lemierre), fascitis necrotizante, meningitis o abscesos metastásicos por diseminación hemática. Las complicaciones supurativas pueden aparecer en un 1,4% de las FAA bacterianas sin tratamiento o tratadas con un antibiótico inadecuado o mal cumplimentado¹⁸.

Se plantea la implicación de gérmenes distintos del EBHGA en relación con complicaciones, por ejemplo *S. anginosus* o *Fusobacterium*¹⁸.

Desde el punto de vista clínico, deberíamos sospechar la posibilidad de una complicación cuando la evolución clínica no sigue un curso satisfactorio

Complicaciones no supurativas

Las complicaciones no supurativas que pueden desarrollarse por infección por estreptococos del grupo A incluyen fiebre reumática aguda y glomerulonefritis postestreptocócica aguda tras un período de latencia de semanas.

En países desarrollados, la incidencia anual es mucho menor que en países en desarrollo, siendo inferior a un caso por cada 100000 habitantes¹⁸. La patología cardíaca de etiología reumática se presenta en el 30%-80% de los pacientes con fiebre reumática y representa la causa más frecuente de patología cardíaca adquirida en países con incidencia elevada.

Los pacientes con más riesgo de fiebre reumática son:

1. Aquellos con antecedentes familiares de fiebre reumática aguda o patología cardíaca reumática.

TABLA 4

Tratamiento según probabilidad de faringoamigdalitis estreptocócica.

Criterios de Centor: 0-2 McIsaac score: 0-2 FeverPAIN score: 0-2	Criterios de Centor: 3 McIsaac score: 3 FeverPAIN score: 3	Criterios de Centor: 4 McIsaac score: 4-5 FeverPAIN score: 4-5
No tratamiento antibiótico	No tratamiento antibiótico de inicio (ofrecer si empeoramiento posterior)	Tratamiento antibiótico inmediato
Test rápido de antígenos (opcional entre 3-15 años) si positivo, tratamiento antibiótico inmediato		

Adaptada de Krüger K, et al¹.

2. Vivienda en hacinamiento.

3. Reciente migración a regiones de alta incidencia (África subsahariana, Asia central o del sur y Oceanía).

4. Grupos poblacionales con alta incidencia de fiebre reumática o alta prevalencia de patología cardíaca reumática.

La glomerulonefritis aguda postestreptocócica es muy rara en países desarrollados y generalmente tiene buen pronóstico y una completa resolución.

Tratamiento

Se complementa con antibiótico según indicación, evaluación de riesgo y en contraste con efectos adversos antes de la administración del tratamiento (tabla 4).

Tratamiento sintomático con corticoides orales

No deberían ser usados como analgésico ni de forma habitual, tomando en cuenta que se trata en su gran mayoría de una patología de evolución autolimitada.

Puede considerarse su uso en pacientes adultos con síntomas severos, por ejemplo, en aquellos con 3-4 criterios de Centor, en una única dosis. No se ha observado efecto significativo en niños. El efecto en este sentido es menor cuando se administra por vía oral, por lo que no se recomienda su uso en atención primaria.

Tratamiento sintomático con antiinflamatorios no esteroideos y paracetamol

El tratamiento se basa en medidas no farmacológicas y con preferencia ibuprofeno o naproxeno como tratamiento sintomático a corto plazo.

Beneficios del tratamiento antibiótico

El dolor de garganta, incluso en etiología bacteriana, no es un criterio general para indicación de tratamiento antibiótico¹.

Se ha demostrado que el beneficio del tratamiento antibiótico es más significativo en la reducción de la duración de los síntomas que en la evitación de las complicaciones.

Este efecto más pronunciado se produce en mayor proporción en pacientes con test rápido de estreptococos positivo que en aquellos con resultado negativo.

Se recomienda la indicación de tratamiento con base en las escalas clínicas.

La prescripción diferida de antibióticos hace referencia a indicarlos solo si los síntomas empeoran o no mejoran tras 3-5 días.

Los antibióticos no reducen la incidencia de complicaciones no supurativas; sin embargo, sí reducen la incidencia de otitis media y absceso periamigdalino en pacientes con FAA bacteriana.

La prevención de complicaciones supurativas no es una indicación específica para el tratamiento antibiótico en el dolor de garganta.

El tratamiento con penicilina ha sido el tratamiento de elección para infecciones faríngeas producidas por estreptococos según las recomendaciones de las guías norteamericanas y europeas dada su eficacia, seguridad, espectro de acción específico y bajo costo.

El uso de amoxicilina es más frecuente en niños pequeños dada su mayor disponibilidad en suspensiones y la adaptación del sabor; sin embargo, puede ser una elección inadecuada en niños mayores ante la posibilidad de una infección por el VEB.

Si se indica tratamiento antibiótico se recomienda penicilina V dos o tres veces al día durante 10 días¹.

Amigdalitis recurrente

Los episodios frecuentes o recurrentes de odinofagia pueden afectar la calidad de vida del paciente y justificar el planteamiento de tratamiento quirúrgico (fig. 2).

Una frecuencia de 7 episodios o más en los últimos 12 meses, se considera una opción la amigdalectomía o amigdalectomía, esto se aplica en pacientes mayores de 3 años.

Si no es posible realizar amigdalectomía o se prefiere evitar la cirugía, se debería intentar en una ocasión el tratamiento de erradicación del patógeno con amoxicilina/ácido clavulánico o clindamicina durante el episodio de odinofagia¹⁹.

Tratamiento antibiótico

Los estreptococos causantes de FAA mantienen hasta la actualidad sensibilidad a las penicilinas. Los macrólidos y las



Fig. 2. Cuadro de amigdalitis vírica con hipertrofia amigdalar y enrojecimiento de los pilares amigdalares. Imagen cedida por los autores.

lincosamidas (clindamicina) son considerados el tratamiento de elección en pacientes alérgicos o con sospecha de alergia a betalactámicos⁹ (tabla 5).

Debe administrarse el tratamiento antibacteriano durante al menos 8 días, aunque preferiblemente se recomienda administrarlo durante 10 días, ya que la mayoría de los estudios se han efectuado con esta duración.

En caso de positividad del Strep A debe recomendarse la utilización de fenoximetilpenicilina o penicilina V (1200000 UI/12 h por vía oral), ya que el EBHGA ha sido y sigue siendo sensible a este antibiótico en todo el mundo²⁰.

En caso de intolerancia al tratamiento de elección, puede administrarse amoxicilina 500 mg/12 h. También puede administrarse una cefalosporina de primera generación como cefadroxilo 500 mg/12 h²¹.

Si hay alergia confirmada a la penicilina se aconseja utilizar la clindamicina 300 mg/8 h durante 10 días o un macrólico: 1 g/12 h durante 10 días.

TABLA 5
Tratamiento específico de la faringoamigdalitis aguda por estreptococo beta hemolítico del grupo A

Tratamiento específico de la faringoamigdalitis aguda por estreptococo beta hemolítico del grupo A	Alternativas	Faringoamigdalitis de repetición
Penicilina v (fenoximetilpenicilina) v.o.: 1,2 M de UI/oral/12 h de 8 a 10 días	Amoxicilina: 500 mg/12 h de 8 a 10 días Cefalosporina de 1ª generación (cefadroxilo: 500 mg/12 h de 8 a 10 días) Alergia confirmada Clindamicina 300 mg/8 h 10 días Macrólidos: 1 g cada 12 h durante 10 días	Amoxicilina/ácido clavulánico 500/125 mg cada 8 h durante 10 días

Adaptada de Cenjor C, et al⁹.

En caso de FAA estreptocócica de repetición se puede administrar la asociación de amoxicilina y ácido clavulánico 500/125 mg/8 h durante 10 días²².

Diagnósticos diferenciales en pacientes con odinofagia

Micosis orofaríngea

Una infección micótica que involucra la orofaringe o el esófago puede ocasionar dolor de garganta, disfagia, náuseas, lengua urente o vómitos. Usualmente no se trata de dolor severo y los microorganismos más frecuentemente involucrados son diferentes especies de *Candida*; sin embargo, existen otros hongos oportunistas como especies de *Aspergillus*²⁰.

Se manifiesta clínicamente como placas blanquecinas que afectan la lengua, las amígdalas y la zona posterior de la faringe o la mucosa oral. El diagnóstico diferencial con leucoplasias se hace por raspado, observando placas desplazables con base eritematosa en la micosis y no desplazables en las leucoplasias.

Los pacientes presentan historia reciente de tratamiento antibiótico, inmunosupresión por corticoides de larga duración o tratamientos inmunomoduladores o enfermedades asociadas a inmunosupresión.

Se inicia tratamiento con antimicóticos sin precisar más evaluación; tratamiento tópico habitual con nistatina 500 000 unidades de 3 a 5 veces al día durante 10 a 14 días; clotrimazol vía oral 10 mg 5 veces al día durante 10-14 días.

Si estas medidas no son efectivas, se recomienda el tratamiento sistémico con fluzonazol 100 mg al día durante 10-14 días o itraconazol 200 mg al día durante 10-14 días, teniendo este último un espectro más amplio.

Estos medicamentos pueden alterar los parámetros analíticos de función hepática y pueden alterar la concentración de medicamentos de metabolismo hepático.

Tonsilolitos

Son depósitos pequeños de sales, bacterias y epidermis que se congregan en las criptas amigdalares. Pueden causar una irritación ipsilateral de la garganta y sensación de cuerpo extraño faríngeo. Frecuentemente se asocian a halitosis.

Enfermedad de Kawasaki

Vasculitis autoinmune pediátrica que se presenta frecuentemente con fiebre elevada, adenopatías, odinofagia y membranas mucosas eritematosas.

Absceso periamigdalino

Se trata de una colección purulenta entre la zona lateral de la amígdala y los músculos constrictores faríngeos. El

síntoma cardinal es el trismus que implica inflamación más allá de la amígdala en el espacio pterigoideo. Se describe mayor dolor en el lado afectado y asimetría amigdalina con abombamiento del paladar.

El tratamiento implica hidratación, incisión y drenaje asociado a antibióticos para cubrir patógenos orales frecuentes, ya que los abscesos tienden a ser polimicrobianos.

Se recomienda tratamiento habitualmente con clindamicina, penicilina, metronidazol y cefalosporinas.

Los abscesos recurrentes (más de 1) precisan amigdalectomía.

Absceso parafaríngeo y retrofaríngeo

Son dos de los más frecuentes abscesos cervicales profundos con presentaciones similares. El absceso parafaríngeo usualmente tiene origen en infecciones faríngeas u odontógenas. Los abscesos retrofaríngeos se originan más frecuentemente de adenopatías de dicho espacio, aunque también puede ocurrir tras traumatismos penetrantes en la pared faríngea posterior.

Una infección faríngea puede preceder la presentación de abscesos retrofaríngeos en 1-3 semanas durante la cual los ganglios previamente inflamados e infectados progresan hasta necrosarse y supurar. Los ganglios retrofaríngeos son prominentes hasta los 4 años de edad y luego empiezan a disminuir de tamaño y fibrosarse.

La presentación habitualmente surge en niños de 4 años de edad que presentan el antecedente de infección respiratoria alta y luego desarrollan rigidez cervical, odinofagia, disfagia y fiebre alta. Pueden presentarse muchos grados de obstrucción de vía aérea y asociarse taquipnea, estridor y estertores.

Puede observarse también inflamación cervical externa y abombamiento de la pared faríngea, aunque este último puede ser muy sutil, especialmente si la exploración está limitada por trismus. Los abscesos parafaríngeos se presentan de forma similar, pero afectan a pacientes mayores que los habituales con abscesos retrofaríngeos.

La zona retrofaríngea es un espacio virtual con potencial progresión rápida y complicaciones hacia los espacios circundantes. Está separado del llamado *Danger space*, se encuentra posterior al espacio retrofaríngeo y se extiende inferiormente hasta el diafragma.

La prioridad en estos casos es la preservación de la vía aérea, y su manejo debe ser determinado y planificado desde el inicio, incluso en aquellos pacientes que parecen estables y sin potencial de complicación.

Una vez evaluada la vía aérea, se puede iniciar el proceso diagnóstico mediante radiografía simple o con mayor sensibilidad mediante tomografía computarizada (TC); se asocia la evaluación analítica y el tratamiento antibiótico de amplio espectro dada la etiología polimicrobiana habitual. Los abscesos parafaríngeos deben ser drenados inmediatamente y comentando previamente con el paciente la posibilidad de una traqueotomía durante la cirugía.

Supraglotitis/epiglotitis

Implica la inflamación de cualquier estructura supraglótica usualmente con origen infeccioso. La incidencia de epiglotitis ha disminuido con el inicio de la vacunación contra *Haemophilus* tipo B.

Los pacientes presentan dolor de garganta, fiebre elevada, odinofagia muy severa y durante la exploración mucha sensibilidad en la zona anterior del cuello, signos de distrés respiratorio y voz gangosa.

Ante la sospecha de epiglotitis se debe centrar el tratamiento en el manejo de la vía aérea, teniendo en mente la posibilidad de una rápida progresión en horas.

Debe evitarse en pacientes pediátricos cualquier procedimiento invasivo como la laringoscopia. Hay que mantener al paciente calmado y confortable. El manejo de la vía aérea se recomienda en quirófano con todas las opciones disponibles y a mano. Si no es posible y la vía aérea precisa asegurarse de forma emergente, se recomienda realizar cricotomía con posterior modificación a traqueotomía.

En adolescentes y adultos puede tolerarse la laringoscopia y más frecuentemente puede manejarse con observación estrecha con o sin intubación en cuidados intensivos. Si se sospecha un absceso deberá realizarse una TAC. Actualmente *S. aureus* y especies de estreptococos son los agentes patógenos más frecuentes en esta entidad.

Se recomienda tratamiento con clindamicina, cefalosporinas y penicilinas resistentes a betalactamasa. Puede estar indicada la administración de corticoides sistémicos, aunque no se ha probado claramente su eficacia en la resolución más rápida de los síntomas.

Reflujo faringolaríngeo

La mucosa de la faringe y de la laringe es más sensible a la pepsina y al ácido que la mucosa gástrica o esofágica. Se plantea el reflujo faringolaríngeo como una entidad diferente al reflujo gastroesofágico. Los síntomas del reflujo faringolaríngeo pueden presentarse sin posición supina y durante el día y en ausencia de los síntomas comunes de reflujo gastroesofágico. Solo un 25% de estos pacientes desarrolla esofagitis. Algunos pacientes sufren de ambas patologías y presentan una mezcla de síntomas.

Se manifiestan como faringitis inespecífica y pueden mostrar irritación crónica, dolor de garganta, sensación de cuerpo extraño y movilización crónica de secreciones asociado a disfonía intermitente. El dolor de garganta puede ser secundario a irritación por tos crónica.

Se recomienda el tratamiento empírico con medidas dietéticas e inhibidores de la bomba de protones durante al menos 2-3 meses para iniciar la observación de efectos. La persistencia de síntomas precisa la evaluación por el especialista en digestivo.

Rinitis

Los síntomas de rinitis o rinosinusitis pueden ser causados por un amplio espectro de patologías. La congestión nasal, la

obstrucción nasal y el goteo nasal posterior pueden contribuir a la irritación y al dolor de garganta crónicos.

El goteo nasal posterior puede causar irritación faríngea, sensación de cuerpo extraño, exceso de flemas o tos crónica con empeoramiento durante la noche o a primera hora de la mañana.

Se asocia más frecuentemente con rinitis alérgica. La insuficiencia respiratoria nasal se relaciona con frecuencia a respiración oral crónica que genera sequedad oral y dolor crónico.

El tratamiento de primera línea implica irrigación nasal con suero salino y corticosteroides tópicos nasales. Si no es suficiente, puede asociarse un antihistamínico intranasal o por vía oral.

Cuerpo extraño

Un cuerpo extraño en la faringe produce sensación de ocupación e irritación bien localizada. Frecuentemente se trata de medicamentos orales de gran tamaño, espinas de pescado o huesos de pollo. La irritación usualmente es autolimitada tras el paso del cuerpo extraño. Las sensaciones persistentes de cuerpo extraño deben evaluarse con radiografías anteroposteriores y laterales del cuello asociadas a laringoscopia.

Los cuerpos extraños en la faringe y laringe precisan extracción. Las materias orgánicas que hayan pasado más allá del cricofaríngeo pueden dejarse continuar hacia el tracto gastrointestinal. Las baterías deben ser extraídas inmediatamente sin importar la localización, dado el potencial daño cáustico que puede generar en el tracto aerodigestivo.

Síndrome de Eagle

Se caracteriza por la presencia de elongación de las apófisis estiloideas o la calcificación del ligamento estiloideo asociado a dolor facial. Es un síndrome que afecta en proporción más frecuentemente a las mujeres entre la cuarta y quinta década de la vida. El dolor es de tipo variable y de características complejas, producido por compresión local de los nervios glossofaríngeo, vago o ramas del trigémino. Habitualmente, en el subtipo clásico se presenta como dolor constante en la garganta, el oído, el cuello o la región temporal, también puede aparecer en relación con cambios en la posición de la cabeza o la palpación de la apófisis estiloidea. Existe también un subtipo carotídeo que implica otros síntomas como mareo, pérdida visual transitoria y síncope cuya descripción queda fuera de los objetivos de esta actualización.

Frecuentemente en el subtipo clásico se describe sensación de cuerpo extraño en la faringe y odinofagia.

Para su diagnóstico se precisa una sospecha clínica inicial a través de síntomas compatibles, palpación de la apófisis en la fosa amigdalina dolorosa, alivio temporal de los síntomas tras la administración de anestesia local y confirmación radiológica.

La longitud habitual de la apófisis estiloidea es de 20-30 mm y de la totalidad de pacientes con evidencia



Fig. 3. Neoplasia maligna de amígdala derecha en paciente varón fumador. Imagen cedida por los autores.

radiológica de elongación de dicha apófisis o calcificación del ligamento estiloideo, menos del 0,5 % presentará síntomas compatibles con el síndrome de Eagle, lo cual sugiere una pobre correlación entre los hallazgos radiológicos y la aparición de clínica. Dadas las características del dolor, es fundamental la evaluación por cirugía oral y maxilofacial para descartar alteraciones de la temporomandibular, puesto que la disfunción de esta se ha descrito en pacientes con síndrome de Eagle.

El tratamiento en casos seleccionados y que cumplan criterios diagnósticos es quirúrgico, aunque se ha descrito una recurrencia de dolor en 20% de los pacientes tratados.

Neoplasias

Tanto las benignas como las malignas pueden generar sensación de cuerpo extraño, irritación o dolor. Las neoplasias benignas frecuentemente causan una sensación de ocupación faríngea y molestias. El dolor es un signo de alarma y aumenta la sospecha de malignidad. Pueden asociarse a disfagia, odinofagia, otalgia, disfonía, pérdida de peso y adenopatías. El tipo más frecuente de neoplasia maligna en la garganta es el carcinoma escamoso (fig. 3).

El dolor es un síntoma clínico esencial durante el diagnóstico inicial de un carcinoma de las vías aerodigestivas superiores. Más del 60% de los pacientes presentan dolor grave a lo largo de su afección tumoral, y más del 80% tienen dolor inicial. Los carcinomas de las mucosas de las vías aerodigestivas superiores producen dolor durante la deglución o la masticación con otalgia unilateral «irradiada», en particular para las lesiones faringolaríngeas o bucales.

El dolor suele acompañar a los pacientes que presentan un tumor maligno de las vías aerodigestivas superiores desde el estadio inicial del diagnóstico hasta el final del tratamiento.

to: el 70% de los pacientes refieren dolor al final del tratamiento. Cualquier dolor que persiste, se modifica o reaparece después del tratamiento inicial obliga a sospechar siempre una progresión evolutiva o una recidiva: el 70% de los pacientes refieren dolor durante una recidiva de su carcinoma.

Responsabilidades éticas

Protección de personas y animales. Los autores declaran que para esta investigación no se han realizado experimentos en seres humanos ni en animales.

Confidencialidad de los datos. Los autores declaran que en este artículo no aparecen datos de pacientes.

Derecho a la privacidad y consentimiento informado. Los autores declaran que en este artículo no aparecen datos de pacientes.

Conflicto de intereses

Los autores declaran no tener ningún conflicto de intereses.

Bibliografía

● Importante ●● Muy importante

✓ Metaanálisis ✓ Artículo de revisión
✓ Ensayo clínico controlado ✓ Guía de práctica clínica
✓ Epidemiología

1. ●● Krüger K, Töpfner N, Berner R, Windfuhr J, Oltrogge JH. Clinical practice guideline: Sore throat. Dtsch Arztebl Int. 2021;118:188-94.
2. Reinholdt K, Rusan M, Rosbjerg P, Ehlers T. Management of sore throat in Danish general practices. BMC Family Practice. (2019): 20:75.
3. ESCMID Sore Throat Guideline Group; Pelucchi C, Grigoryan L, Galeone C, Esposito S, Huovinen P, Little P, et al. Guideline for the management of acute sore throat. Clin Microbiol Infect. 2012;18Suppl1:1-28. doi: 10.1111/j.1469-0691.2012.03766.x.
4. ●● Chan T. The patient with sore throat. Med Clin N Am. 2010; 94:923-43.
5. Linder JA, Chan JC, Bates DW. Evaluation and treatment of pharyngitis in primary care practice: the difference between guidelines is largely academic. Arch Intern Med. 2006;166(13):1374-9.
6. Malo S, Bjerrum L, Feja C, Lallana MJ, Moliner J, Rabanaque MJ. Compliance with recommendations on outpatient antibiotic prescribing for respiratory tract infections: the case of Spain. Basic Clin Pharmacol Toxicol. 2015;116(4):337-42.
7. Adriaenssens N, Bartholomeeusen S, Ryckebosch P, Coenen S. Quality of antibiotic prescription during office hours and out-of-hours in Flemish primary care, using European quality indicators. Eur J Gen Pract. 2014;20(2):114-20. doi: 10.3109/13814788.2013.828200.
8. Cenfor C, García-Rodríguez JA, Ramos A, Cervera J, Tomás M, Asensi F, et al. Documento de consenso sobre "tratamiento antimicrobiano de la faringoamigdalitis". Acta Otorrinolaringológica Española. 2003;54(5):369-83.
9. Tran J, Danchin M, Steer AC, Pirota M. Management of sore throat in primary care. Aust J Gen Pract [Internet]. 2018;47(7):485-9. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.31128/AJGP-11-17-4393>
10. Andersen JS, Borrild NJ, Hoffmann S. Potential of antigen detection tests. BMJ. 1995;310(6971):58-9.
11. Wessels MR. Streptococcal pharyngitis. New Engl J Med. 2011;17;364(7): 648-55.
12. Pelucchi C, Grigoryan L, Galeone C, Esposito S, Huovinen P, Little P, et al. Guideline for the management of acute sore throat. Clin Microbiol Infect. 2012;18(1):1-27.
13. ● Piñeiro Pérez R, Hijano Bandera F, Álvarez González F, Fernández Landaluze A, Silva Rico JC, Pérez Cánovas C, et al. Documento de

- consenso sobre el diagnóstico y tratamiento de la faringoamigdalitis aguda. *An Pediatr*. 2011;75(5):342.e1-13.
14. Dingle TC, Abbott AN, Fang FC. Reflexive culture in adolescents and adults with group A streptococcal pharyngitis. *Clin Infect Dis*. 2014;59(5):643-50.
 15. ● **Cots JM, Alós JI, Bárcena M, Boleda X, Cañada JL, Gómez N, et al. Recomendaciones para el manejo de la faringoamigdalitis aguda del adulto. *Acta Otorrinolaringol Esp*. 2015;66 (3) 159-70.**
 16. Bisno AL. Acute pharyngitis: etiology and diagnosis. *Pediatrics*. 2023;97(6 Pt 2):949-54.
 17. Ebell MH, Smith MA, Barry HC, Ives K, Carey M. The rational clinical examination. Does this patient have strep throat? *JAMA*. 2000;284(22):2912-8.
 18. Goossens H, Ferech M, Vander Stichele R, Elseviers M. Outpatient antibiotic use in Europe and association with resistance: a cross-national database study. *The Lancet [Internet]*. 2005;365(9459):579-87.
 19. Prades JM, Gavid M. Dolor en otorrinolaringología. *EMC - Otorrinolaringol*. 2018;47(1):1-19.
 20. Shulman ST, Bisno AL, Clegg HW, Gerber MA, Kaplan EL, Lee G, et al. Clinical practice guideline for the diagnosis and management of group A streptococcal pharyngitis: 2012 Update by the Infectious Diseases Society of America. *Clin Infect Dis*. 2012;55(10):e86-102.
 21. Llor C, Hernández Anadón S, Gómez Bertomeu FF, Santamaria Puig JM, Calviño Domínguez O, Fernández Pagés Y. Validación de una técnica antigénica rápida en el diagnóstico de la faringitis por estreptococo beta hemolítico del grupo A. *Aten Primaria*. 2008;40(10):489-94.
 22. Costelloe C, Metcalfe C, Lovering A, Mant D, Hay AD. Effect of antibiotic prescribing in primary care on antimicrobial resistance in individual patients: systematic review and meta-analysis. *BMJ*. 2010;340:c2096-6.